



Travma Sonrası Büyüme Etkileyen Faktörler

Factors Affecting Growth After Trauma

Elmas Merve Malas^{1*} , Elif Can Sünbül²

¹ Psikoloji Bölümü, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, 42080 Konya, Türkiye

² Ömer Kömürcü İmam Hatip Ortaokulu, 19040 Çorum, Türkiye

MAKALE BİLGİLERİ

Gönderim Tarihi: 14/07/2025
Kabul Tarihi: 13/11/2025

Atıf:
Malas, E. M., & Sünbül, E. C. (2025).
Travma Sonrası Büyüme Etkileyen
Faktörler. *Acad. Rev. Hum. Soc. Sci.*
8(2), 109-126.

*Sorumlu yazar: Elmas Merve MALAS
E-mail: malasmerve@gmail.com

Anahtar Kelimeler / Keywords:
Travma / Trauma
Travma Sonrası Büyüme / Post-
Traumatic Growth
Travma Sonrası Büyüme Etkileyen
Faktörler / Factors Affecting Post-
Traumatic Growth

© Telif hakkı 2005 Bursa Teknik
Üniversitesi'ne aittir. Çevrimiçi olarak
ulaşılabilir: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/arhuss>



ARHUSS'da yayınlanan eserler
Creative Commons Atıf - Ticari
Olmayan 4.0 Uluslararası Lisansı
kapsamında lisanslanmıştır.

ÖZET

Travma, bireyin gerçek bir ölüm ya da ölüm tehdidi yaşaması, ağır yaralanma veya bedensel bütünlüğüne yönelik tehditlerle ya da cinsel istismarla karşılaşması ya da bu durumlara tanık olması şeklinde tanımlanır. Bu tür olaylar yalnızca acı, sıkıntı ve travma sonrası stres bozukluğu gibi olumsuz sonuçlar doğurmakla kalmaz; aynı zamanda travma sonrası büyüme ve gelişim için de bir zemin oluşturabilir. Travmatik olayla baş etme süreci ve bu mücadelenin sonucunda ortaya çıkan olumlu değişimler, travma sonrası büyüme (TSB) olarak adlandırılmaktadır. TSB, bireyin zorlu yaşam olaylarıyla başa çıkması sonucunda kişisel gelişiminde ve yaşam perspektifinde meydana gelen olumlu dönüşümleri ifade eder. Bu çalışmada travma sonrası büyüme kavramı; kuramsal temeli, alt boyutları, etkileyen faktörler ve benzer kavramlarla birlikte ele alınmıştır. TSB kavramının anlaşılması, travmatik yaşantılar sonrasında uygulanacak müdahalelerin niteliğini ve etkinliğini artırması bakımından büyük önem taşımaktadır. Kişilerin travmatik olaylar sonrasında süreçle baş etmesindeki diğer örtük kavramlarında netleştirilmesi önemlidir.

ABSTRACT

Trauma is defined as experiencing an actual death or threat of death, severe injury, or threats to bodily integrity, as well as exposure to or witnessing sexual assault. Such events not only lead to adverse outcomes such as pain, distress, and posttraumatic stress disorder (PTSD) but may also provide a foundation for posttraumatic growth (PTG) and development. The process of coping with traumatic events and the positive changes that emerge because of this struggle are referred to as posttraumatic growth. PTG represents positive transformations in personal development and life perspective that occur as individuals cope with highly challenging life experiences. In this study, the concept of PTG is discussed in terms of its theoretical foundations, subdimensions, influencing factors, and related constructs. Understanding PTG is critical, as it enhances the quality and effectiveness of interventions following traumatic experiences. Moreover, clarifying other implicit concepts associated with individuals' coping processes after trauma is also essential.

1. Giriş

Psikolojik ve duygusal alandaki travma, bireyin bilişsel, duygusal ve duygusal işlevlerinde belirgin sınırlılıklara yol açarak gündelik yaşamını sürdürmesini güçleştiren ruhsal bir yaralanma olarak tanımlanmaktadır (Ruppert, 2014). Judith Herman (2020) psikolojik travmayı “Hem doğal dünyadaki insan yaralanabilirliği hem de insan doğasındaki kötülük kapasitesiyle yüz yüze gelmektir” şeklinde tanımlamıştır. Travma kavramı DSM-5-TR tanı kriterlerinde “kişinin gerçek bir ölüm tehdidi alması, ağır yaralanması, fizik bütünlüğünü tehdit eden bir olay yaşaması, başka bir kişinin ölümü, ölüm tehdidi altında kalması, yaralanması ya da fizik bütünlüğünü tehdit eden bir olaya tanıklık etmesi, ailesinden birinin ya da başka bir yakınının beklenmedik ölümü, şiddete maruz kalarak öldürülmesi, ağır yaralanması, ölüm ya da yaralanma tehdidi altında kaldığını öğrenmesi gibi kişinin doğrudan yaşadığı ve bu travmatik olay karşısında kişide dehşet, korku ve çaresizlik duygularının ortaya çıkması durumu” olarak tanımlanmıştır (American Psychological Association (APA), 2022). Kişinin kendi güçsüzlüğüyle yüzleşmesi ve karşı konulmaz bir güç karşısında çaresiz kalması, bireyin kendisi, dünya ve başkaları hakkındaki temel inançlarını sarsabilecek birçok farklı olay da “travmatik” olarak algılanabilir.

Travma; travmatik olayın süresi ve belirtilerin ortaya çıkış zamanlarına göre akut ve kronik ya da gecikmeli başlangıçlı travma şeklinde sınıflandırılabilir (APA, 1980). Travmalarda fizyolojik, psikolojik ve duygusal olarak insanlar farklı tepkiler verebilmektedirler. Bazı kişiler zorluklar karşısında psikolojik esnekliğe sahip olup, durumu kabullenir ve çözüm yolları bulmaya çalışır; bazıları ise bu zorlukla baş edemeyerek travma sonrası strese varabilecek tepkiler verir (Schultz vd., 2016). Travmatik olaylar acıya, sıkıntıya ve “Travma Sonrası Stres Bozukluğuna” (TSSB) neden olabildiği gibi travma sonrası psikososyal bakımdan büyüme ve gelişmeyi de sağlayabilir (Tedeschi & Calhoun, 2004). Birçok insan zorlayıcı olaylarla başa çıkma sürecinde, bir büyüme deneyimi yaşadığını bildirmiştir (Schulenberg, 2020). Travmatik olayla mücadele ile bu mücadelenin sonucu olarak ortaya çıkan pozitif değişimler ve edinimler, travma sonrası büyüme olarak adlandırılmaktadır (Tedeschi & Calhoun, 2004). Bu olumlu değişiklikler; anlamlı ve sağlıklı kişilerarası ilişkiler kurabilme, daha zengin varoluşsal ve manevi yaşam, takdir görme, artan psikolojik güçlülük duygusu, önceliklerde değişim, öncelikleri tekrar belirleme, anlam bulma, ilişkilerin iyileştirilmesi ve psikolojik güçlenme gibi şekillerde kendisini göstermektedir (Bossick, 2008).

Alanyazında “travma sonrası büyüme” ve “travma sonrası gelişim” kavramlarının aynı anlamda kullanıldığı görülmektedir (Dekel, Ein-Dor & Solomon 2012; Duman, 2019; Erten & Kocakaya, 2020; Gülyol, 2024). Çalışmada travma sonrası büyüme kavramı kullanılacaktır. Herhangi bir travmatik yaşantı deneyimlemek, tek başına travma sonrası büyüme (TSB) için yeterli değildir. Travmatik olay dışında, bireysel özelliklerin (olayın süresi, yoğunluğu, algılanan şiddeti, olayla nasıl başa çıkıldığı), çevresel kaynakların (algılanan sosyal destek, maddi kaynaklar) ve travmatik olaya ilişkin değişkenlerin (olayın süresi, yoğunluğu, algılanan şiddeti) TSB oluşmasında etkili olduğu vurgulanmaktadır (Abraido -Lanza, Guier & Colon, 1998).

Bu çalışmada travma ve travma sonrası büyüme ve gelişmeyi etkileyen faktörler konusu; Literatürden edinilen bilgiler eşliğinde “travmatik olayın türü ve şiddeti, sosyodemografik özellikler, travma sonrası stres belirtileri, algılanan sosyal destek, başa çıkma stratejisi, kişilik özellikleri, umut ve iyimserlik, psikolojik sağlamlık (hardiness), dayanıklılık (resilience), iyimserlik (optimism) ve duygusal tutarlılık algısı (sense of coherence)” başlıkları altında tartışılması amaçlanmıştır.

1.1. Travma Kavramı ve Tarihsel Gelişimi

Travma, yazılı tarihten çok önce bile insan deneyiminin doğal bir parçası olmasına rağmen, travmatik yaşantıların insan yaşamı üzerindeki etkilerinin fark edilmesi görece yakın tarihlerde mümkün olmuştur (Levers, 2012). Travma kavramının bilimsel olarak incelenmesi 1870’li yılları bulmaktadır. 1870 yılındaki Fransa-Prusya savaşı sonrasında cepheden dönen askerlerin psikolojik sorunlar yaşaması hekimlerin dikkatini çekmiştir (Veith, 1977). Travmanın fiziksel sorunlar dışında psikolojik etkilerinin de olabileceği düşüncesi ilk kez bu savaştan sonra fark edilmiş ve bu askerlerdeki belirtiler tanımlanmaya çalışılmıştır. Psikiyatristlerin gözlemlediği bu davranışlar TSSB belirtilerini hatırlatmaktadır. Psikiyatristler bu belirtiler gösteren kişilere ilk kez “travmatik nevroz” tanısını koymuştur (Norman, 1989).

Charcot, travmanın psikolojik etkilerini, histeri hastalarında ortaya çıkan çok sayıda bedensel ve ruhsal belirti aracılığıyla fark etmiştir (Levine, 2017). Charcot ve Janet’ten sonra, histeri konusunda en çok çalışan araştırmacı Avusturya’da Breuer ile çalışmalar yapan Freud olmuştur. Freud’un ilk kuramsal yaklaşımları, psikoloji tarihinde travma kuramı olarak adlandırılmıştır. Freud’a göre,

bireylerin geçmişte yaşadıkları ancak bilinç düzeyinde ifade edemedikleri anılar, daha sonraki süreçte hatırlandığında travmatik etki yaratmaktadır (Habip, 2019).

Travma kavramı tarihsel süreçte tartışmalara konu olmuş ve zaman içerisinde önemli değişimlere uğramıştır. Bu değişim, yayımlanan DSM'lerde de izlenebilmektedir (Wilson, 1994). Örneğin, zorlu yaşam olaylarının "travma" olarak adlandırılması ilk kez DSM-III'te yer almıştır (APA, 1980). Daha sonraki süreçte, travma DSM-5-TR'te çok daha ayrıntılı bir biçimde tanımlanmıştır (APA, 2013).

1.2. Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB)

TSSB, travma sonrasında kişide korku, çaresizlik ya da dehşete düşme tepkilerine neden olan psikolojik bir bozukluktur (Özgüler vd., 2004). İnsanların yaşadığı travmaların sonuçları geniş çaplı psikolojik etkilere sebep olabilir. Öncesinde herhangi bir yardıma ihtiyacı olmayan insanlar zorlu yaşam olayları sonucunda yardım gereksinimi duyabilirler. Buna ek olarak, travma öncesinde zaten hassas durumda olan grupların (ruhsal hastalığı olanlar, engelliler, azınlıklar vb.) olaydan etkilenme düzeyleri de farklı olacaktır (Karancı vd., 2009) Zorlu yaşam olayının türüne ve kişinin travmayı algılama şekline göre etki ve sonuçları farklılaşır (Tedeschi & Calhoun, 2004). Anormal duruma, anormal tepki vermek normaldir. Travma sonrasında bazı insanlar kısa bir sürede toparlanırken bazıları için eski işlevselliğine dönme süresi daha uzun olabilir. Öyle ki kişinin gösterdiği belirtiler TSSB kısaltma kullanılmalı gibi sonuçlara kadar gidebilir. (Schultz vd., 2016). TSSB, travmatik olayı tekrar tekrar yaşama, örseleyici olayla ilişkili uyaranlardan kaçınma ve aşırı uyarılmışlık belirtileri ile karakterizedir (Bolu, Erdem & Öznur, 2014). Travmatik olayların yalnızca TSSB'ye değil; depresyon, kaygı bozuklukları, dissosiyatif bozukluklar gibi farklı ruhsal sorunlara da yol açabilmektedir (Kashdan, Morina & Priebe, 2009).

1.3. Travma Sonrası Büyüme (TSB)

TSB, zorlu bir yaşam olayı ile mücadele etmenin sonucunda bireyde meydana gelen olumlu değişimi ifade etmektedir (Calhoun & Tedeschi, 1999). Birçok insan zorlayıcı olaylarla başa çıkma sürecinde, bir büyüme deneyimi yaşadığını bildirmiştir (Schulenberg, 2020). Travmatik olaylar ne kadar sarsıcı olursa olsun olumlu etkileri ve sonuçları da olabilmektedir (Shakespeare-Finch vd., 2003). Travmatik olaylar acıya, sıkıntıya ve TSSB'ye neden olabildiği gibi TSB sağlayabilir. Travmatik olayla

mücadele ile bu mücadelenin sonucu olarak ortaya çıkan pozitif değişimler ve edinimler, TSB olarak adlandırılmaktadır. Bu olumlu değişiklikler; anlamlı ve sağlıklı kişilerarası ilişkiler kurabilme, takdir görme, artan psikolojik güçlülük duygusu, önceliklerde değişim, daha zengin varoluşsal ve manevi yaşam gibi şekillerde kendisini göstermektedir (Bossick, 2008; Tedeschi & Calhoun, 2004).

TSB pek çok şekillerde tanımlanmıştır. Bu tanımlar TSB'nin; örseleyici olaylarla mücadelenin sonucunda gerçekleşen bu pozitif değişiklikler ve deneyimlerin olduğu (Zoellner & Maercker, 2006), bu olaylar sonrasında, bireyin yaşamında daha iyi işlevsellik göstermesi ve kendini gerçekleştirmek adına adımlar atmasını sağlayan (Joseph & Linley, 2005), öncelikleri tekrar belirleme, anlam bulma, ilişkilerin iyileştirilmesi ve psikolojik güçlenme gibi önemli pozitif değişikliklerin meydana gelmesine katkıda bulunan (Shakespeare-Finch vd., 2003), yeni perspektifler geliştirmeyi ve kişisel büyümeyi içeren (Kleim & Ehlers, 2009), olumlu bilişsel, duygusal, davranışsal bir dönüşüm süreci (Özlü, Yıldız & Aker, 2010) olduğunu ortaya koymaktadır.

Travma Sonrası Büyüme (TSB), bireyin örseleyici yaşam olaylarına karşı dayanıklı olması, bu olaylardan daha az etkilenmesi ya da süreci yalnızca iyi yönetmesinden farklı olarak, bir değişim ve dönüşüm sürecini ifade etmektedir (Tedeschi & Calhoun, 2004). TSB ile ilişkili kavramlar arasında psikolojik dayanıklılık (resilience), psikolojik sağlamlık (hardiness) ve duygusal tutarlılık algısı (sense of coherence) yer almakla birlikte, bu kavramlar TSB'den ayrılmaktadır (Almedom, 2004).

TSB, travmatik bir olayın ardından ortaya çıkan olumlu değişimleri ifade ederken; dayanıklılık, sağlamlık ve duygusal tutarlılık daha çok bireyin kişilik özellikleriyle ilişkili, süreklilik gösteren eğilimlerdir. Dolayısıyla bu özelliklere sahip bireylerde travmatik yaşantılardan sonra gözlenen olumlu sonuçlar, çoğunlukla TSB'den ziyade kişilik özelliklerinin etkisiyle açıklanmaktadır.

Travmatik olaylar bireylerde acıya, sıkıntıya ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu'na (TSSB) yol açabileceği gibi, uygun koşullarda TSB'ye de zemin hazırlayabilir.

1.4. Travma Sonrası Büyümeyi Açıklayan Yaklaşımlar

Zorlayıcı ve travmatik yaşam olaylarından sonra insanlarda gözlenebilecek olumlu değişiklikler çeşitli

kuramcılar tarafından farklı modellerle açıklanmaya çalışılmıştır. Bu yaklaşımlar, Schaefer ve Moos (1992) tarafından geliştirilen Yaşam Krizleri ve Kişisel Gelişim Modeli, Tedeschi ve Calhoun'un (1996) İşlevsel-Betimsel Modeli, Joseph ve Linley'nin (2005) geliştirdiği Travma Sonrası Büyümenin Organizmik Değerlenme modeli, Park ve Ai'nin (2006) Anlam Oluşturma Modeli ve Joseph, Murphy ve Regel'in (2012). Duygusal-Bilişsel İşleme Modeli olarak gruplanabilir.

1.4.1. Yaşam Krizleri ve Kişisel Gelişim Modeli

Bu modele göre, travma sonrası büyüme ve uyum süreçlerinde yaşam krizleri önemli bir rol oynamaktadır. Modele göre kişisel ve çevresel faktörler yaşam krizlerinin oluşumuna zemin hazırlar. Yaşam krizleri, bireylerin değerlendirme ve başa çıkma mekanizmalarını harekete geçirir; bu mekanizmalar ise pozitif sonuçlar ve travma sonrası büyüme ile ilişkilidir. Yaklaşımda her bir aşama, diğer tüm aşamalardan etkilenmekte ve aynı zamanda onları etkilemektedir (Schaefer & Moos, 1998). Bu çerçevede, yaşanan krizler gelişmiş sosyal kaynaklar, kişisel güçlenme ve başa çıkma becerilerinin artması gibi olumlu sonuçlar doğurabilmektedir (Schaefer & Moos, 1992).

1.4.2. Travma Sonrası Büyümenin İşlevsel-Betimsel Modeli

Calhoun & Tedeschi (1996) literatürdeki araştırmaları inceleyerek travma sonrası büyümeyi açıklamak amacıyla Betimsel İşlevsel Model'ini geliştirmişlerdir. İlk olarak 1995 yılında geliştirdikleri modeli 2004 yılında yenilemişler ve 2018 yılında ise son haline ulaşmışlardır. Tedeschi & Calhoun'a (1996) göre travma sonrası büyüme, travmanın doğrudan bir sonucu değil; bireyin travma sonrasında ortaya çıkan yeni durumla başa çıkma sürecinin bir ürünüdür.

Travma Sonrası Büyüme (TSB) sürecinde bireyin travma öncesindeki olumlu kişilik özellikleri ve psikolojik sağlığı önemli bir rol oynar. Zorlayıcı yaşantılarla karşılaşıldığında duyguların farkında olmak, ruhsal iyilik hali, psikolojik esneklik, zihinsel işleme kapasitesi, iyimserlik ve değişime-gelişime açık olma gibi özellikler TSB'nin temelini oluşturmaktadır. Ayrıca bireyin travma öncesinde kullandığı başa çıkma yöntemleri, gerçekçi hedeflere sahip olup olmaması ve işlevsel inançlara sahip bulunması, yeni yaşantıyla nasıl mücadele edeceğini belirleyen unsurlardır.

Travmatik deneyim sonrasında kişi, başlangıçta otomatik bir ruminasyon sürecine girer. Beyin, olayı tekrarlayıcı biçimde gündeme getirerek yaşantıyı anlamlandırmaya çalışır. Bu aşamada travmanın etkisiyle kaybolan kontrol duygusunu yeniden kazanma çabası ön plana çıkar. Sürecin ilerleyen safhalarında ise istemli bir ruminasyon ve bilgi işleme süreci başlar. Birey travmatik yaşantıyı zihinsel olarak işler ve bu işleme pozitif değişime zemin hazırlar. Bu süreç devam ettikçe birey, eski yaşamının değiştiğini fark eder ve yeni gerçekliğe uyum sağlamaya yönelir.

Ruminasyon ve başa çıkma sürecine ek olarak, bireyin sıkıntılarını paylaşması, sosyal destek alması, kendini düzenleme becerilerini kullanması, yeni işlevsel şemalar geliştirmesi ve etkili başa çıkma yöntemlerine başvurması süreci olumlu yönde destekler. Bu aşamada kişi, kişisel yaşam öyküsünü yeniden yapılandırır, yeni şemalar geliştirir ve daha işlevsel bir bakış açısı kazanır. Sonuçta yaşamın anlamını yeniden oluşturduğu bir çözülme gerçekleşir. Süreç tamamlandığında birey, daha düşük düzeyde travma sonrası stres tepkileri gösterir ve travma sonrası büyüme gerçekleşmiş olur (Tedeschi, Shakespeare-Finch, Taku & Calhoun, 2018).

1.4.3. Organizmik Değerlendirme Modeli

Bu model travma sonrası büyüme ve gelişmeyi sosyal-bilişsel olarak açıklamayı amaçlayan Joseph ve Linley (2005) tarafından geliştirilmiştir. Model insanların zorlu yaşam olaylarından sonra pozitif bir yaşam sürdürme konusunda kendini motive edebilen bir yapıya sahip olduklarını savunur. Bu kurama göre insanlar iyi olanı bilme konusunda içsel bir inanca sahiptir ve travmalardan sonra büyüme eğilimleri vardır. Kişiler yaşadıkları deneyimleri anlamlandırır ve yeni bir benlik oluştururlar. Bu model Tamamlama Eğilimi, Asimilasyon ve Uyumsama, Anlamlandırma ve İyi Oluş olmak üzere dört teorik temel üzerine inşa edilmiştir (Joseph & Linley, 2005).

Joseph ve Linley'nin (2005) modeline göre, travmatik bir deneyimden sonra bireylerin yaşadığı bilişsel ve duygusal süreçler, travma sonrası büyümenin (TSB) ortaya çıkışında belirleyici bir rol oynar. Bu süreç birkaç temel mekanizma ile açıklanır:

Öncelikle bireyler, travma ile ilgili ortaya çıkan yeni bilgiyi geçmişte sahip oldukları bilişsel yapılarla bütünleştirme ihtiyacı hissederler. Bu birleştirme eğilimi "tamamlama eğilimi" olarak adlandırılır ve organizmik değerlendirme sürecinin önemli bir parçasıdır. Bireyin var olan inanç sistemleri ile yeni

deneyimi bir araya getirmesi, travmanın anlamlandırılmasında kritik rol oynar.

Travma sonrası bilişsel uyum süreci iki şekilde gerçekleşebilir: asimilasyon ya da uyum (akomodasyon). Asimilasyonda birey, yaşadığı travmayı mevcut inanç sistemine katı bir şekilde dahil etmeye çalışır. Bu durum bireyin travma öncesi seviyesine geri dönmeye yol açabilir, ancak aynı zamanda gelecekteki travmalara karşı daha savunmasız kalmasına ve katı savunmalar geliştirmesine neden olabilir. Bu nedenle asimilasyon, genellikle travma sonrası büyümeyi desteklemez. Buna karşılık uyum süreci, travmanın mevcut inanç sisteminde değişikliklere yol açmasıdır. Negatif uyumda kişi, travma sonrasında depresyon, kaygı bozuklukları veya kişilik sorunları geliştirebilir. Pozitif uyumda ise travmatik deneyim, bireyin yaşamında yapıcı bir dönüşüme yol açar; kişi daha çok “anı yaşayabilen,” ilişkilerine değer veren ve hayata daha pozitif yaklaşan bir birey haline gelir. Bu pozitif uyum, TSB’nin temelini oluşturur.

Bu süreç aynı zamanda anlamlandırma ihtiyacıyla da desteklenir. Birey, travma sonrası yaşantıyı anlaşılır hale getirmek ve zihinsel olarak bütünleştirmek ister. “Meaning as comprehensibility” kavramında da vurgulandığı gibi, olayın nedenlerini ve sonuçlarını kavramak, bireyin deneyimi anlamlı bir çerçeveye oturtmasına yardımcı olur.

Son aşamada, birey travmayı olumlu bir şekilde uyarlayıp anlamlandırabildiğinde psikolojik iyi oluş ortaya çıkar. Bu noktada sosyal destek hem anlamlandırma sürecini kolaylaştırır hem de bireyin olumlu uyumunu pekiştirir. Dolayısıyla model, travma sonrası büyümeyi yalnızca bireysel bilişsel süreçlerle değil, aynı zamanda sosyal kaynaklarla da ilişkilendirmektedir.

1.4.4. Park’ın Anlam Oluşturma Modeli

Park ve Ai (2006) ‘Anlam Oluşturma Modeli’ni Victor Frankl’ın geliştirmiş olduğu anlam arayışı ve logoterapi yaklaşımından (1969) hareketle oluşturmuşlardır. Frankl’a göre insan, yaşamına devam edebilmek için anlam aramayı ve yorumlamayı, diğer insanların yaşamına değer katmayı kaynak almıştır. Bu model, stres ve travma sonrasında meydana gelen büyümenin nasıl gerçekleşeceğinin dayanağını oluşturur. Park, travma sonrası büyüme kavramını kullanmak yerine ‘stresle ilgili büyüme’ kavramını kullanmıştır (Park, 2004). Bunun sebebi stres daha sık karşılaşılan ve daha yaygın kullanılan bir kavram olmasıdır (Park vd., 2009).

Anlam bulma kişinin genel inançlarının, amaçlarının ya da zorlayıcı olayın yeniden değerlendirilmesi sürecinde ortaya çıkar. Dünyaya ilişkin varsayımlar ve sıkıntı verici olaya ilişkin inançlar çatışır ve anlam oluşturma süreci başlar. Bu iki inanç sistemindeki çatışmayı azaltmak için çaba gösteren kişi yeni bir anlam dünyası inşa eder. Fakat her zaman kişinin bulduğu anlam olumlu olmaz. TSB’nin meydana gelebilmesi için kişinin bulduğu anlam olumlu olmalıdır (Werdel & Wicks, 2012).

1.4.5. Duygusal-Bilişsel İşleme Modeli

Joseph, Murphy ve Regel (2012) 2005 yılında geliştirmiş oldukları Organizmik Değerlendirme Modeli’ni alandaki diğer bulgular ve yaklaşımlardan hareketle 2012’de yenileyerek “Duygusal-Bilişsel İşleme Modeli” olarak güncellemişlerdir. Bu yaklaşıma göre, stres travmatik büyüme için gereklidir. Travmatik stres sonrasında kişinin zihni, uyuşmazlığı gidermek için bir ruminasyon süreci yaşar. Bununla birlikte bilişsel işleme sürecinde belli bir duygu durum ortaya çıkar ve bu duygulanım süreçte kullanılacak baş etme yöntemlerinin türünü belirler. Örneğin; travmatik olaya ilişkin hissedilen pişmanlık hissi, onarıcı davranışları başlatabilirken; öfke, korku, kaygı kaçınma davranışlarına neden olmaktadır (Joseph, vd., 2012).

Duygusal-Bilişsel İşleme Modeli’ne göre travma sonrasında var olan uyuşmazlığın çözülmesi için tekrarlayıcı ruminasyonlardan yansıtıcı düşünceye geçilmesi gerekmektedir. Kişi yansıtıcı düşünme sürecine geçtikten sonra zihinsel olarak bu yaşantıyla ilgili yeni anlamlar oluşturulur ve uyuşmazlıklar çözülür. Dolayısıyla kişisel yaşam öyküsü tutarlı ve anlamlı bir biçimde yeniden oluşturulur. Bu yaklaşımda Organizmik Değerlendirme Modelinde (Linley & Joseph, 2004) olduğu gibi var olan durum ile travmanın sağladığı güncel bilgiler arasındaki uyuşmazlık asimilasyon ya da uyum sağlama sürecinden geçer. Kişi uyum sağladıktan sonra dönüşüm ve değişim süreci başlar ve “Dünya güvenilmez bir yerdir” gibi inançlar, yerini ‘Güvenebileceğim insanları seçebilirim.’ şeklindeki sağlıklı düşüncelere bırakır. Dolayısıyla kişiler psikolojik olarak güçlenir ve hayatla ilgili yeni anlamlar bulabilir. Bu kuramın en önemli katkısı zorlu yaşam olaylarında yararlı olabilecek terapötik müdahalelere önem vermesi ve insanların travmatik yaşantıyla baş etmesine ve travma sonrası büyüme yaşamasına katkı sağlamasıdır (Altınsoy, 2020).

1.5. Travma Sonrası Büyüme ve Alt Boyutları

Travma Sonrası Büyüme “kendilik algısı, kişilerarası ilişkiler ve yaşam felsefesi” olmak üzere üç temel alanda ortaya çıkmaktadır (Tedeschi ve Calhoun, 1996). Tedeschi ve Calhoun’un (1996) beş faktör analizi ile yaptıkları bir araştırma sonucunda TSB’nin Kişisel Güç (Personal Strength), Yaşamın Değerini Anlama (Appreciation of Life), Başkalarıyla İlişkiler (Relating to Others), Yeni İmkanlar (New Possibilities) ve Manevi/Varoluşsal Değişim (Spiritual/Existential Change) olmak üzere beş boyuttan oluştuğu ortaya çıkmıştır. Travmatik yaşantı sonrasında oluşacak olan büyüme ve gelişme bu beş boyutun tümünde gerçekleşmeyebilir ya da sadece bazı alt boyutlarda gerçekleşebilir (Tedeschi & Calhoun, 2004).

Kişisel Güç: Travma yaşayan kişinin bu yaşantının sonucunda artan benlik saygısını ifade etmektedir. Bireyler travmatik deneyimin etkisiyle birlikte benlik saygısında olumlu bir değişim algılar. Daha sonra karşısına çıkabilecek benzer zorluklarla mücadele edebilecek güce sahip olduğunu fark eder. Psikolojik olarak güçlenir. Travmatik yaşantılara maruz kalan kişiler bir yandan kişisel olarak ne kadar güçlü olduklarının farkına varırken diğer taraftan yaralanmaya ne kadar açık olduklarını da fark ederler (Tedeschi, Park & Calhoun, 1998). Zorlayıcı olaylara maruz kalan kişiler bu durumu genellikle şöyle ifade ederler: “Düşündüğümde daha savunmasızım ama hayal ettiğimden çok daha güçlüyüm.” (Calhoun & Tedeschi, 1999). Yara almaya açık olduğunu fark etmek, travmanın olumlu bir etkisi olarak görülmeyebilir. Ancak yaralanmayacak kadar güçlü olduğuna inanmak tehlikelidir ve travmatik stres tepkisidir (Tedeschi & Calhoun, 1996).

Yaşamın Değerini Anlama: Bu boyut kişinin yaşamın olduğu haliyle değerli olduğunu kavradığı, anda kalabilme becerisini kazandığı, bilinçli farkındalığa ulaştığı bir süreci ifade eder. Kişiler kayıp ve acıyla karşı karşıya kalmanın öncesinde herhangi bir uyarı olmadan kötü bir olayın gerçekleşebileceğini ve bunu kontrol edemeyeceğini fark eder.

Başkalarıyla İlişkiler: Kişiler travmatik yaşantının ardından diğer insanlarla daha derin bağlar kurabilirler. Aslında insani ilişkilerin ne kadar önemli olduğunu ve insanların birbirine ihtiyacı olduğunu kavrarlar. Özellikle acı çeken insanlara karşı daha fazla merhamet ve sempati hissedebilirler. Yakınlık ve yaşantılarını paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu fark eder. Dolayısıyla daha anlamlı ve sağlıklı ilişkiler geliştirir (Bossick, 2008).

Yeni İmkanlar: Bu boyutta kişinin yeni hedeflere odaklanması, yeteneklerini fark etmesi ve farkındalık

becerisi kazanması söz konusudur. Öyle ki kişi hangi hedeflere ulaşabileceğini, hangilerine ulaşamayacağını ve neleri başarabileceğini fark eder (Tedeschi & Calhoun, 2004).

Manevi/Varoluşsal Değişim: İnsanlar acı veya ölümle karşılaştıktan sonra varoluşsal bir sorgulamaya girerler. Bunun neden kendi başına gelmiş olabileceğini düşünürler. İnançlarını sorgular ve travmaya dair anlam bulmaya çalışırlar. Bütün bunlar manevi konularda daha fazla farkındalık kazanmalarına ve kendi sorumluluklarını fark etmelerine neden olur. Önceliklerinin farkına varır ve hayata daha fazla değer vermeye başlarlar (Janoff-Bullman, 2006). Buna ek olarak dindar olmayan ya da ateist olan kişiler de varoluşsal sorgulamalara girer ve spiritüel alanda travma sonrası büyüme yaşayabilirler (Tedeschi & Calhoun, 2004).

1.6. Travma Sonrası Büyümeyi Etkileyen Faktörler

Travmatik yaşantılar zorlayıcı olmakla birlikte birçok insan travma sonrası büyümeyi deneyimleyebilmektedir. İlgili alanyazın incelendiğinde TSB’yi etkileyen çok fazla etken göze çarpmaktadır. Yapılan araştırmalar ve alanyazın taraması sonucunda TSB’yi etkileyen faktörler, olay ile ilişkili özellikler (olayın süresi, yoğunluğu, algılanan şiddeti, olayla nasıl başa çıkıldığı), kişisel kaynaklar (kişilik özellikleri, demografik özellikler, travma öncesi deneyimler) ve çevresel kaynaklar (aile ve diğerlerinden algılanan sosyal destek) olarak gruplanabilir (Bossick, 2008). Bu çalışmada travma sonrası büyüme ve gelişimi etkileyen faktörler; Travmatik Olayın Türü ve Şiddeti, Sosyodemografik Özellikler, Travma Sonrası Stres Belirtileri, Algılanan Sosyal Destek, Başa Çıkma Stratejisi, Kişilik Özellikleri, Umut ve İyimserlik, Psikolojik Sağlamlık (Hardiness), Dayanıklılık (Resilience), Duygusal Tutarlılık algısı (Sense of Coherence), başlıkları altında gruplanmıştır.

1.6.1. Travmatik Olayın Türü ve Şiddeti

Travmatik yaşantının türü ve şiddetiyle ilgili yapılan çalışmalar, olayın türünün (deprem, sel gibi) daha ölümcül olması ve şiddetinin daha fazla olması (kaybın büyüklüğü) ile travma sonrası büyüme arasında daha güçlü bir ilişki bulmuşlardır. Olay ne kadar tehlikeli ve kayıp ne kadar büyükse travma sonrası büyüme o kadar fazladır (Linley & Joseph, 2004; Dürü, 2006; Armstrong & Shakespeare-Finch, 2011).

Janoff-Bullman'a (2006) göre, travmanın kişinin yaşamındaki hipotezlerine etki edecek kadar güçlü olması TSB için gereklidir. Örneğin kanser hastaları ile yapılan bir araştırmada TSB ile hastalığın şiddeti arasında pozitif yönde anlamlı ilişki saptanmıştır. (Andrykowski vd., 1996). Benzer şekilde yakınlarını kaybeden kişilerle yapılan bir araştırmada birinci derece yakınını kaybeden insanların ikinci dereceden yakınını ya da bir arkadaşını kaybedenlere göre daha fazla TSB gösterdiği bulunmuştur. Dolayısıyla kayıp ne kadar büyük algılanıyorsa, TSB'nin o kadar fazla olduğu ortaya çıkmıştır (Armstrong & Shakespeare-Finch, 2011).

Bu süreçte önemli olan kişinin deneyimlediği bu yaşantıyı ne kadar şiddetli algıladığıdır. Bazı çalışmalar ise travmanın şiddetine ek olarak kişinin burada algıladığı tehdit seviyesinin TSB'yi olumlu yönde etkilediğini ortaya koymuştur (Linley & Joseph, 2004). Dürü (2006) yaptığı çalışmada deprem gibi doğal afetler deneyimleyen insanların trafik kazası gibi insan eliyle olan daha az şiddetli travma yaşayanlara göre daha fazla TSB deneyimlediklerini ortaya koymuştur.

1.6.2. Sosyodemografik Özellikler

Yapılan araştırmalara bakıldığında, yaş (Helgeson Reynolds & Tomich, 2006), cinsiyet/kadın olmak (Tedeschi & Calhoun, 1996), eğitim seviyesi (Bellizzi & Blank, 2006; Linley & Joseph, 2004), evli olmak (Bellizzi & Blank, 2006) gelir düzeyi (Karancı, Aker & Işıklı, 2009) gibi sosyodemografik değişkenler ile TSB arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Bu çalışmalara ek olarak cinsiyetin TSB üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığını ortaya koyan çalışmalar da mevcuttur (Helgeson vd., 2006; Polatinsky & Esprey, 2000). Benzer şekilde yaşın büyük olmasının (Powell, Rosner, Butollo, Tedeschi & Calhoun, 2003; Carver & Antoni, 2004) ve yaşın daha genç olmasının (Bellizzi & Blank, 2006) daha fazla TSB'ye yol açtığını belirten araştırmalar çelişkili sonuçlar vermektedir.

1.6.3. Algılanan Sosyal Destek

Yapılan birçok çalışmada algılanan sosyal destek ile TSB arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur (Linley & Joseph, 2004; Schroevers, Helgeson, Sanderman & Ranchor, 2010; Schmidt vd., 2012). Buna ek olarak TSB'si yüksek olan kişilerde sosyal destek arama olasılığı da yüksek bulunmuştur (Barskova & Oesterreich, 2009). Dolayısıyla hem sosyal destek almak TSB'yi hem de TSB sosyal destek almayı pozitif yönde etkiliyor denebilir.

Maguen, Vogt, King, King ve Litz'e (2006) göre sosyal destek insanların yalnızlık hissini hafifleterek TSB'yi olumlu yönde etkilemektedir. Ayrıca sosyal yönden alınan destek kişinin çevreden aldığı olumlu bir davranış olduğu için travmayla başa çıkmayı ve TSB'yi kolaylaştırmaktadır (Calhoun, Cann & Tedeschi, 2010). Sosyal destek kişilere travmatik olayla ilgili geri bildirim sağlayabildiği için bunun bir tür bilişsel destek sayılabileceğini ifade eden çalışmalar da (Cryder vd., 2006; Tedeschi & Calhoun 2004) bulunmaktadır. Travmatik stres seviyesi arttıkça algılanan sosyal desteğin arttığı ve algılanan sosyal destek arttıkça da travma sonrası büyüme ve gelişmenin arttığı vurgulanmaktadır (Özcan & Arslan, 2020).

1.6.4. Başa Çıkma Stratejisi

Tedeschi ve Calhoun'un (1996) İşlevsel-Betimsel Model'ine göre, insanların yaşadıkları zorlayıcı yaşam olayını nasıl yönettiğine dair başa çıkma stratejileri önemli bir role sahiptir. Başa çıkma stratejileri 'Probleme odaklanan başa çıkma stratejileri' ve 'Duyguya odaklanan başa çıkma stratejileri' olarak iki kategoride gruplanabilir (Carver & Scheier, 1994; Ptacek, Smith & Zanas, 1992). Probleme odaklanan başa çıkma stratejisi aktif bir yöntem olup stres karşısında bilgiye ve planlı davranışlara odaklı akılcı tepkileri içerir. Duyguya odaklanan başa çıkma stratejisi ise pasif bir strateji olup stres karşısında ortaya çıkan duyguları ortadan kaldırmayı amaçlar. İnsanlar stres karşısında her iki başa çıkma stratejisini de kullanmaktadır (Carver & Scheier, 1994). Ayrıca kullanılan stratejiler bireysel farklılıklara göre değişiklik gösterebilir (Savcı & Aysan, 2014). İnsanlar stresle başa çıkarken planlı bir şekilde davranıp problemi çözmeye çalışma, sosyal destek arama, stresi ortaya çıkaran durum veya olaydan kaçınma, stres oluşturan durum veya olayı kendine saklama eğiliminde olma, sorumluluğu kabul edip kendine yönelme, kadercilik ve doğaüstü güçlere inanış veya batıl inanışlarla hareket etme gibi stratejiler kullanmaktadır (Folkman & Lazarus, 1985).

İlgili alanyazın incelendiğinde, başa çıkma yöntemleri açısından inkâr, kendini suçlama, davranışsal kopma gibi olumsuz başa çıkma yöntemleri TSB ile negatif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur (Bussell & Naus, 2010). Bununla birlikte olumlu yeniden yapılandırma ve problem odaklı başa çıkma (Stockton, Hunt & Joseph, 2011); duygusal destek almayı içeren duygusal başa çıkma ve olumlu manevi/kabullenici başa çıkma (Linley & Joseph, 2004); diğer insanların da başına benzer şeylerin geldiğini düşünme gibi işlevsel başa çıkma

stratejileri (Currier, Lisman, Irene Harris, Tait & Erbes, 2013) ile TSB arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur.

Olumlu ve aktif başa çıkma stratejileri sayesinde kişiler olayın anlamını yeniden değerlendirebilir, kendi önceliklerini, sosyal ilişkilerini yeniden gözden geçirir ve dolayısıyla TSB gerçekleşmiş olur (Ezerbolat & Özpolat, 2016).

1.6.5. Kişilik Özellikleri

Kişilik, bireyi diğerlerinden ayıran ve gelecekteki davranışlarını öngörmemizi sağlayan tutarlı eğilimlerdir (Augustine & Larson, 2012). Beş Faktör Kişilik Modeli'ne göre kişilik; özdenetim, uyumluluk, dışadönüklük, gelişime açıklık ve nörotisizm olmak üzere beş boyuttan oluşur (Benet-Martinez & John, 1998).

- Özdenetim: Sorumluluk sahibi, çalışkan ve güvenilir olma.
- Uyumluluk: Fedakâr, empatik ve iş birliğine açık olma.
- Dışadönüklük: Sosyal, enerjik ve girişken olma.
- Gelişime açıklık: Yenilikçi, yaratıcı ve entelektüel olma.
- Nörotisizm: Kaygı, kararsızlık, olumsuz duygu ve düşük yaşam doyumu eğilimi.

Araştırmalar, özdenetim, uyumluluk, dışadönüklük ve gelişime açıklığın yüksek düzeyde TSB ile ilişkili olduğunu; yüksek nörotisizmin ise düşük TSB ile bağlantılı bulunduğunu göstermektedir (Linley & Joseph, 2004; Helgeson vd., 2006; Karancı vd., 2012). Ayrıca, dışadönüklük, gelişime açıklık ve uyumluluk düzeyi yüksek bireyler travmatik olaylarla daha etkili başa çıkmakta ve sosyal destek arayışında daha aktif olmaktadır (Prati & Pietrantoni, 2009).

1.6.6. Umut ve İyimserlik

Umut, geleceğe dair olumlu sonuçlar bekleme eğilimi olup, bireylerin amaç edinmesini, hedeflerine ulaşmasını ve zorluklara uyum sağlamasını destekleyen bilişsel bir süreçtir (Snyder, Irwing & Anderson, 1991; Çetinceli & Mücevher, 2023). Somut hedefler belirleme, bu hedeflere yönelik çaba gösterme ve iradeyi kullanma süreçlerini içerir. Umut, aynı zamanda TSB'ye katkıda bulunan önemli bir koruyucu faktör olarak görülmektedir (Snyder vd., 1996).

İyimserlik ise bireyin genellikle olumlu sonuçlar bekleme eğilimi olup, psikolojik iyi oluşa katkı sağlayan bir mizaç özelliğidir (Scheier & Carver, 1987; Harju & Bolen, 1998). Olumsuz olaylar karşısında bile olumlu beklenti içinde olmak hem ruhsal hem de bedensel sağlığı korur (Seligman, 2007) ve TSB ile güçlü bir ilişki göstermektedir (Helgeson, Reynolds & Tomich, 2006). İyimser bireyler daha esnek olup sorunlara uyum sağlama konusunda avantajlıdır.

Çeşitli çalışmalar umut ve iyimserlik düzeyi yüksek bireylerde TSB'nin de daha yüksek olduğunu bildirmiştir (Helgeson vd., 2006; Dürü, 2006; Hobfoll vd., 2007; Confino, Einav & Margalit, 2023). Sonuç olarak, umut ve iyimserlik hem zorluklarla baş etmeyi kolaylaştıran hem de travma sonrası büyüme ve gelişimi destekleyen koruyucu faktörlerdir (Tarhan & Bacanlı, 2015).

1.6.7. Psikolojik Sağlamlık (Hardiness)

Psikolojik sağlamlık (PS) sıkıntılı veya zorlu yaşam stresörlerine karşı olumsuz etkilerin üstesinden gelebilme, uyum sağlayabilme, bunlarla baş edebilme, tekrar eski işlevselliğine ve gelişimine geri dönebilme ve sürdürebilme olarak tanımlanmaktadır (Wagnild & Collins 2009; Wu, vd., 2013; Wright & Masten, 2015).

Teorik olarak, TSB ve PS alanyazında sıkça karıştırılmaktadır (Tedeschi, Calhoun, & Cann, 2007). Örneğin, travma sonrası büyümenin bir tür dirençlilik olup olmadığı ve büyümenin dirençlilikten üstün olup olmadığı tartışılmaktadır (Lepore & Revenson, 2006; Tedeschi vd., 2007; Westphal & Bonanno, 2007). Literatürde de TSB ile PS arasında pozitif (Bensimon, 2012; Min vd., 2014) ve negatif bir ilişkinin olduğunu (Levine vd., 2009) gösteren farklı çalışmalar bulunmaktadır. Buradan sonuçla TSB ile PS arasındaki ilişki hakkında farklı bulguların mevcut olduğu görülmektedir.

TSB, yaşanan olumsuzlukların ardından kişide ortaya çıkan pozitif bir değişimi temsil eder (Tedeschi & Calhoun, 1996). PS ise travmaya rağmen başa çıkma becerisini kolaylaştıran geniş bir kişisel özellikler kümesini ifade eder. Bu özellikler arasında psikolojik dayanıklılığın yanı sıra iyimserlik, kendini yüceltme, baskılayıcı başa çıkma, pozitif etki ve duygusal tutarlılık duygusu da bulunmaktadır (Agaibi & Wilson, 2005; Tedeschi & Calhoun, 2004). Bu özellikler topluca, bu tür kişilerin travmadan daha az psikolojik yaralarla ve değişimle çıkmalarını sağlar. Bu nedenle, TSB'nin gelişmesi için, bir kişinin örneğin iyimser, dayanıklı olması ve geri dönüşü

olmayan değişiklikleri temsil eden yaşam krizleriyle yüzleşmesi gerektiği gibi aynı zamanda psikolojik açıdan sağlam olması yeni bir uyum seviyesine ulaşması için gereklidir.

TSB üzerine yapılan birçok çalışma, TSB'yi açıkça veya örtük olarak psikolojik sağlamlıkla eşitlemiş veya bir adım daha ileri giderek TSB'yi PS sonuçlarından üstün olarak değerlendirmiştir. Örneğin, Carver (1998) PS'yi zorluklardan sonra önceki işlevsellik seviyesine geri dönmek olarak tanımlayarak TSB ile PS'yi ayırt etmiş ve TSB'yi sadece önceki seviyeye geri dönmekle kalmayıp aynı zamanda bu seviyeyi aşmakla ilişkilendirmiştir. Bu tanım, TSB'nin gerçekleşmesi için, bir kişinin önce PS göstermesi ve sağlıklı bir işlevsellik seviyesine geri dönmesi gerektiğini, daha sonra daha yüksek ve daha verimli işlevsellik seviyelerine ulaşabileceğini varsaymaktadır.

Ancak literatürde tüm bu açıklamaların tersine psikolojik sağlamlık, bir kişinin kendisine veya dünya görüşlerine yönelik tehdit algılamasını daha az olası hale getirebilir. Bu nedenle daha psikolojik sağlamlığa sahip insanlar, olayın etkisini hafifletmekte daha başarılıdır. Buna göre, büyüme, travmatik bir olayı anlamlandırma ihtiyacıysa (Tedeschi & Calhoun, 1996, 2004), psikolojik sağlamlığa sahip insanlar, travmanın sonuçlarıyla mücadele etmeyecekleri için büyüme ile ilişkili anlamlandırma davranışlarında bulunma olasılıkları daha düşüktür (Bonanno, Wortman, & Nesse, 2004). Bu nedenle, psikolojik sağlamlığa ait sonuçların travma sonrası büyüme için çok az ihtiyaç veya fırsat sağlayabileceği ileri sürülmüştür. Bu da TSB ve PS arasındaki negatif ilişkiyi açıklamaktadır. Benzer şekilde TSB ve PS'nin iki bağımsız yapı olduğu, PS'ye sahip kişilerin diğer travma geçirmiş kişilerle aynı ölçüde mücadele etmedikleri için TSB'nin bir sonucu olan yaşadıklarına anlam yükleme davranışlarını gerçekleştirmediklerini ileri sürmekte ve TSB'nin ancak travmadan etkilenen ve travma sürecinde mücadele eden kişilerde görülebileceğini belirtmektedirler (Westphal & Bonanno, 2007).

1.6.8. Dayanıklılık (Resilience)

Kobasa (1979) çalışmasında yüksek düzeyde strese maruz kalan ancak psikopatolojiye sahip olmayan insanlar, sağlıklı bireyler stres altında hasta olan kişilerden farklı bir kişilik yapısına sahip olduğundan bahsetmektedir. Bu kişilik farkının "dayanıklılık" terimiyle tanımlanabileceğini söylemektedir. Dayanıklı kişilerin üç genel özelliğe sahip olduğu kabul edilmektedir. Bunlar deneyimlerinin, olayları kontrol edebilmeye veya etkileyebilmeye olan inanç,

yaşamlarının faaliyetlerine derinlemesine dahil olma veya bağlılık hissetme yeteneği ve değişimi daha fazla gelişim için heyecan verici bir meydan okuma olarak görme beklentisi olarak belirtilmektedir. Dayanıklılık travmatik olayların sonrasında olumlu sonuçları etkileyebilecek olası bir faktördür. Stres karşısında bireysel farklılıkları inceleyen önceki çalışmalar, psikolojik dayanıklılığı sağlıklı ve sağlıklı tepki verenleri ayıran bir faktör olarak tanımlamıştır (Kobasa, 1979).

Dayanıklılığın ağır yaralı askerler ve eşlerinde TSB ile ilişkili olduğu söylenmektedir (Bartone & Bowles, 2021). Dayanıklılığı yüksek olan kişiler dünyaya karşı güçlü bir bağlılık ve katılım duygusuna sahiptir ve hayatı anlamlı ve değerli görürler. Tedeschi ve Calhoun (1996) TSB'den bahsederken "yaşamın değerini anlama" alt boyutundan bahsetmektedirler. Ayrıca dayanıklılığa sahip kişiler güçlü bir kontrol duygusuna sahip olup, hayatın kesintileri ve engellerini aşılması ve öğrenilmesi gereken zorluklar olarak görme eğilimindedirler. Dayanıklılığı yüksek olan ağır yaralı askerler ve eşlerinin yaşadıkları zorlukları olumlu bir şekilde yorumlama, yaralanmalarından kurtulma ve hayatlarına devam etme olasılığı daha yüksek bulunmuştur (Bartone & Bowles, 2021). Dayanıklılığın, hayatı değiştiren yaralanmalar karşısında olumlu bir bakış açısını sürdürmeye yardımcı olan değerli bir kaynak olduğunu önermektedir (Tedeschi & Calhoun, 1995, Bartone & Bowles, 2021).

Psikolojik dayanıklılık travmatik deneyimlerden sonra bireyin baş etmesini sürdürmesinde ve travma sonrası büyüme eğilimi göstermesinde belirleyici bir kişilik özelliği olarak bahsedilmektedir (Linley & Joseph, 2004; O'Leary, Alday & Ickovics 1998; O'Leary & Ickovics, 1995; Tedeschi & Calhoun, 1995, 2004). Farklı travmatik olay deneyimleyen kişilerle yapılan çalışmalarda, dayanıklılığın travma sonrası büyüme düzeylerinde aracı rol oynadığı görülmektedir (Song & Lee, 2011, Cole & Lynn, 2010; Salim, Wadey & Diss, 2015).

Psikolojik dayanıklılık, travmatik deneyimler karşısında benliği korur ve kişisel gelişimi desteklemede önemli bir rol oynar (Kobasa, 1979; Kobasa vd., 1982; Maddi, 2005). Kavramsal olarak ise psikolojik dayanıklılık, potansiyel felaketlerin yol açtığı stres ve gerginliği, kişisel büyüme fırsatlarına dönüştürmeye yardımcı olan strateji ve becerilere cesaret ve motivasyon sağlayan tutumların bir birleşimi olarak tanımlanır (Maddi, 2006). Başka bir deyişle, psikolojik dayanıklılık stresli ve zor yaşam olaylarına uyum sağlama başarısı, travmatik tehditleri sağlık durumunda herhangi bir bozulma olmadan

aşma yeteneği ve zor koşullarda bile görev ve sorumluluklarını yerine getirme kabiliyeti gibi güçlü kişilik özelliklerinin bir ifadesidir. Buna göre, zor yaşam olaylarında psikolojik dayanıklılık, bireyin zihinsel sağlığını korumak için bir tampon etkisi gösterir. Dayanıklı birey zor olayı daha az stresli olarak yorumlar (Kobasa vd., 1982).

Alanyazında psikolojik dayanıklılık, stresli durumlarla baş etme becerileri için de önemlidir. Krizin tanımlanması ve yönetilmesinde kullanılan başa etme kaynaklarını şekillendirilmesine yardımcı olur (Maddi, 2002, 2005; Schaefer & Moos, 1992). Bu nedenle, psikolojik dayanıklılık bireylerin zor yaşam olaylarını çeşitli başa çıkma mekanizmaları aracılığıyla fırsatlara dönüştürmesini sağlayan bir faktördür (Maddi, 2002; O'Leary vd., 1998). Psikolojik dayanıklılığın meydan okuma bileşeni krizin fırsata dönüştürülmesini sağlamaktadır. Pozitif başa çıkma yöntemleri, sorun çözmeye yönelik problem odaklı başa çıkma becerileri ve mutluluğu artıran stratejiler bireyi daha olumlu bir yere taşımada işlev görme açısından birbirleriyle yakından ilişkilidir (Tedeschi & Moore, 2016). Sonuç olarak, birey psikolojik dayanıklılığa sahip ise travma sonrası büyümeyi deneyimleme gücüne ulaşma imkânı daha fazladır (Werdell & Wicks, 2012).

1.6.9. Duygusal Tutarlılık Algısı (Sense of Coherence)

Duygusal tutarlılık algısı (DTA), bireyin olayları çözümleyebilme, anlamlandırabilme, başa çıkabilme ve onlardan anlam çıkarabilme kapasitesini ifade etmektedir (Antonovsky, 1997). DTA düzeyi yüksek olan bireyler stresle daha etkili başa çıkabilmektedir (Amirkhan & Greaves, 2003). Antonovsky (1984), hastalıkların nedenlerinden ziyade sağlığın kaynaklarını açıklamaya odaklanmış ve bireylerin stresle baş edebilmek için “genelleştirilmiş direnç kaynaklarını” (ego, bilgi, sosyal bağlar, değerler, inançlar, vb.) harekete geçirdiğini öne sürmüştür. DTA; anlaşılabilirlik, yönetilebilirlik ve anlamlılık olmak üzere üç boyuttan oluşmaktadır.

DTA'nın çocuklukta gelişmeye başladığı, ergenlikte çekirdeğinin oluştuğu ve yetişkinlikte nispeten sabit kaldığı belirtilmektedir (Antonovsky, 1984). Radikal yaşam olayları sonrasında bile yalnızca geçici dalgalanmalar gözlenmektedir (Lindblad vd., 2016). Bu yönüyle DTA, kişilik özelliğine benzer bir yapı olarak değerlendirilmektedir. Ölçekten elde edilen puanlar bireylerin dünyayı ne ölçüde tutarlı veya tutarsız algıladığını göstermekte ve sağlıklı işlevsellik açısından belirleyici olmaktadır.

Rutter'a (1985) göre dayanıklılık, stresten kaçınmakla değil, uygun şekilde strese maruz kalmakla gelişir. Bu bakış açısı, Antonovsky'nin anlam duygusu kavramıyla örtüşmektedir. Nitekim Tedeschi ve Calhoun (2004), anlam duygusunun bireylerin travmatik koşulları kavramasını, onlarla başa çıkmasını ve yaşamda yeni anlamlar bulmasını kolaylaştırdığını, dolayısıyla TSB'nin önemli bir yordayıcısı olabileceğini ileri sürmektedir.

Alanyazında DTA ve TSB ilişkisine dair farklı bulgular bulunmaktadır. Bazı çalışmalar DTA'nın özellikle anlamlılık boyutunun TSB ile pozitif ilişkili olduğunu göstermektedir (Arya & Davidson, 2015), bazıları ise düşük DTA ile yüksek TSB arasında negatif ilişki bildirmiştir (Brockhouse vd., 2011). Ayrıca, DTA ve TSB arasında anlamlı bir ilişki bulamayan araştırmalar da mevcuttur (Linley & Joseph, 2007; Linley vd., 2005). Bu nedenle, gelecekte yapılacak çalışmaların DTA'nın boyutları ile TSB arasındaki ilişkileri daha ayrıntılı biçimde ele alması önemlidir (Ragger vd., 2019).

1.7. TSSB ve TSB İlişkisi

TSSB ve TSB arasındaki ilişki uzun süredir araştırmaların odağında yer almaktadır. Alanyazında bu ilişkiye dair farklı bulgular rapor edilmiştir. Bazı çalışmalar TSB ile TSSB arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermektedir (Dekel, Ein-Dor & Solomon, 2012; Dürü, 2006; Min vd., 2014). Buna karşın, bazı araştırmalar negatif bir ilişki bulmuştur (Butler vd., 2005; Yi & Kim, 2014). Bir çalışmada ise bu iki değişken arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (Widows vd., 2005). Ancak, alanyazındaki daha güncel değerlendirmeler, TSSB ile TSB arasında hiçbir ilişkinin olmadığına dair bulguları reddetmektedir (Shakespeare-Finch & Lurie-Beck, 2014).

Alanyazındaki bulgular arasındaki bu farklılık, TSSB ile TSB arasında eğrisel (curvilinear) bir ilişki olasılığını gündeme getirmiştir. Nitekim bu olasılık doğrulanmış ve ters “U” biçimli bir ilişki ortaya konmuştur. Buna göre, yüksek TSB puanları hafif düzeyde TSSB semptomlarıyla ilişkiliyken, düşük TSB puanları hem düşük hem de yüksek TSSB semptomlarıyla ilişkili bulunmuştur (McLean vd., 2013). Bu bulgular, literatürde hem doğrusal (Calhoun vd., 2010; Kleim & Ehlers, 2009; Solomon & Dekel, 2007) hem de eğrisel (Butler vd., 2005; Lechner vd., 2006) ilişki olduğuna dair kanıtları desteklemektedir.

Her ne kadar TSSB ile TSB arasındaki ilişkiler istatistiksel olarak anlamlı olsa da bu ilişkiler güçlü

değildir. Bu durum, travma mağdurlarının yaşadığı büyüme düzeyini ve sürdürdükleri sıkıntıyı etkileyen pek çok farklı faktörün varlığına işaret etmektedir (Shakespeare-Finch & Lurie-Beck, 2014). İstatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin bulunması, bu ilişkinin pratikte veya psikolojik açıdan da anlamlı olduğu anlamına gelmemektedir.

Araştırmalar, düşük veya yüksek düzeyde büyüme bildiren kişilerin, orta düzeyde büyüme bildirenlerle kıyasla daha az semptom rapor ettiğini göstermektedir. Orta düzeyde büyüme, mağdurların travmanın sonuçlarını olduğundan daha az yıkıcı görerek kendilerini rahatlatma ve semptomları küçümseme eğilimini yansıtabilir. Bazı bireyler travmayı bir kriz olarak değerlendirmeyebilir; bu durum da hem düşük semptom hem de düşük büyüme skorlarını açıklayabilir.

Bu bağlamda, Maercker ve Zoellner (2004), TSB'nin kimi zaman reddetme, kaçınma veya arzuya dayalı düşünceyle ilişkili yanılmalı ve kısmen kendini aldattıcı bir yönü olabileceğini ileri sürmüştür. Benzer şekilde Taylor (1983) ve Taylor ve Armor (1996), yaşamı tehdit eden durumlarda kişilerin kendilerine ilişkin hafif çarpıtılmış olumlu algılar, abartılı kişisel kontrol duygusu ve gerçekçi olmayan iyimserlik geliştirebildiğini göstermiştir. Taylor ve diğerleri (2000), bu tür olumlu çarpıtmaların kimi zaman olumlu sonuçlarla ilişkili olduğunu belirtmiş olsa da böyle bir güvence travmanın etkilerini aşmada her zaman yardımcı olmayabilir.

Bulgular aynı zamanda Janoff-Bulman'ın (1992) "varsayımların sarsılması" hipotezini de desteklemektedir. Bu hipoteze göre, travma öncesi temel inançları sarsılan bireylerde hem olumsuz hem de olumlu değişimlerin ortaya çıkması beklenir. Travmaya kalıcı bir anlam yükleyen bireyler, yaşamlarında yeni anlamlar ve yönler aramaya motive olabilir; bu da algılanan büyümeyi kolaylaştırmaktadır. Nitekim travma sonrasında bireyler bazen yeni anlamlar geliştirmekte, bazen de çarpıtılmış olumlu algılar yoluyla uyum sağlamaya çalışmaktadır.

Westphal ve Bonanno (2007), dayanıklı (resilient) sonuçların genellikle TSB'ye olan ihtiyacı azalttığını vurgulamıştır. Dolayısıyla, travmaya olumlu ya da olumsuz anlam yükleyen bireylerde TSB'nin ortaya çıkabileceği öngörülmektedir. TSB, travma sonrasında daha iyi uyum ve daha düşük psikopatolojiye katkıda bulunabilir. Ancak, büyümenin raporlanması tek başına uyumun kesin bir göstergesi değildir.

Öte yandan, TSB'nin psikopatoloji için bir öncül mü yoksa bir sonuç mu olduğu tartışmalıdır. Genellikle sıkıntının erken dönemde başladığı, büyüme deneyimlerinin ise travmadan sonraki daha ileri evrelerde ortaya çıktığı bilinmektedir. Bununla birlikte, bazı araştırmalar olumlu değişimlerin —örneğin empati artışı, hayata daha fazla değer verme ve ilişkilerde iyileşme— travmadan yalnızca iki hafta sonra bile gözlenebildiğini göstermektedir (Frazier vd., 2001). Bu nedenle, travmatik bir olayın ardından psikopatoloji ve büyüme büyük olasılıkla birbirini karşılıklı olarak etkilemekte, kimi zaman da farklı hızlarda ve bağımsız biçimde gelişebilmektedir (McLean vd., 2013).

2. Sonuç

Travma, yaşamın kaçınılmaz bir parçasıdır. Bireyler yaşamları boyunca farklı düzeylerde birçok travmatik olaya maruz kalmakta ya da bu olaylara tanıklık etmektedir. Travma deneyimleyen kişiler farklı tepkiler gösterebilir; bazı bireyler Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) geliştirirken, bazıları travma sonrası büyüme (TSB) süreci yaşamaktadır. Bu farklılıkların nedenlerinin açıklığa kavuşturulması, travmaya müdahale eden uzmanlara önemli katkılar sağlayacaktır.

TSB kavramı, travma yaşamış kişilere yönelik müdahaleler için önemli bir bilgi kaynağıdır. Alanyazında TSB ile ilgili çalışmaların büyük bir kısmı büyümeyi etkileyebilecek faktörlere odaklanmaktadır (Almedon, 2005; Prati & Pietrantonio, 2009; Karancı vd., 2012). Bu bağlamda psikolojik sağlamlık (hardiness), dayanıklılık (resilience), iyimserlik (optimism) ve duygusal tutarlılık algısı (sense of coherence) gibi kavramların TSB ile ilişkili olduğu vurgulanmaktadır. Ancak, bu kavramlar zaman zaman TSB ile karıştırılmaktadır. Örneğin, psikolojik sağlamlık bir kişilik özelliği, dayanıklılık ise daha çok süreçsel ve adaptif bir kapasite olarak tanımlanmaktadır. Bu ayrımların netleştirilmesi, TSB'nin daha doğru anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.

Travma sonrası büyümenin daha iyi anlaşılabilmesi için ölçüm araçlarının geliştirilmesi, metodolojik sınırlılıkların aşılması ve özellikle boylamsal ile nitel araştırmalara ağırlık verilmesi gerekmektedir. Şimdiye kadar yapılan sınırlı sayıda çalışmalara rağmen, duygusal tutarlılık algısı (Almedon, 2005; Walsh, 2011; Arya & Davidson, 2015), psikolojik sağlamlık ve dayanıklılığın TSB üzerindeki etkilerini ortaya koyacak daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Günümüzün hızla değişen koşulları, bireylerin yeni stres kaynaklarıyla başa çıkabilmek için bu tür

psikolojik kaynaklarını geliştirmesini zorunlu hale getirmektedir.

Alanyazında, TSB ile sosyal destek arasındaki ilişkinin tutarlı biçimde desteklendiği görülmektedir. Ancak TSB ile sosyodemografik değişkenler (örneğin yaş ve travma türü) arasındaki bulgular çelişkilidir. Bu nedenle, özellikle travma türü ve yaş gibi değişkenlerin boylamsal olarak ele alınması önem taşımaktadır. Ayrıca, mevcut çalışmalarda öz-bildirim yanlılığına dikkat edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

Makale Bilgileri

Finansal Açıklama: Yazar(lar) bu çalışmanın araştırılması, yazarlığı veya yayınlanması için herhangi bir finansal destek almamıştır.

Yazarların Katkıları: Konsept: EMM., Tasarım: EMM., ECS.; Danışmanlık: EMM.; Kaynaklar: EMM., ECS.; Literatür Taraması: EMM., ECS.; Makale Yazımı: EMM., ECS.; Eleştirel İnceleme: EMM.,

Çıkar Çatışması/Ortak Çıkar: Yazarlar tarafından herhangi bir çıkar çatışması veya ortak çıkar beyan edilmemiştir.

Etik Komite Onayı: Bu çalışma etik kurul izni veya herhangi bir özel izin gerektirmemektedir.

Kaynaklar

Abraido-Lanza AF, Guier C, Colon RM. (1998). Psychological thriving among Latinas with chronic illness. *Journal of Social Issues*, 54, 405-24.

Agaibi, C. E., & Wilson, J. P. (2005). Trauma, PTSD, and resilience: A review of the literature. *Trauma, Violence, & Abuse*, 6(3), 195-216.

Almedom, A. M. (2004). Factors that mitigate war-induced anxiety and mental distress. *Journal of Biosocial Science*, 36(4), 445-461.

Almeida, M., Ramos, C., Maciel, L., Basto-Pereira, M., & Leal, I. (2022). Meaning in life, meaning-making and posttraumatic growth in cancer patients: Systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Psychology*, 13, 995981.

Altınsoy, F. (2020). *Travmatik deneyimi olan bireyler için bir travma sonrası büyüme modeli*. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.

Amirkhan, J. H., & Greaves, H. (2003). Sense of coherence and stress: The mechanics of a healthy disposition. *Psychology and Health*, 18(1), 31-62.

Andrykowski MA, Curran SL, Studts JL, Cunningham L, Carpenter JS, McGrath PC, Sloan DA, Kenady DE. (1996). Psychosocial adjustment and quality of life in women with breast cancer and benign breast problems: a controlled comparison. *J Clin Epidemiol*, 49(8), 827-34. doi: 10.1016/0895-4356(96)00028-5.

Antonovsky, A. (1984). A call for a new question—salutogenesis—and a proposed answer—the sense of coherence. *Journal of Preventive Psychiatry*, 2, 1–13.

APA (American Psychiatric Association) (1980). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (3th ed.). Washington, DC: Author.

APA (American Psychiatric Association) (2022). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed. revised). Washington, DC: Author.

APA (Amerikan Psikiyatri Birliği) (2013). *Ruhsal bozuklukların tanılma ve sayımsal elkitabı*, Beşinci Baskı (DSM-5), Tanı ölçütleri başvuru elkitabı. Hekimler Yayın Birliği: Ankara.

Armstrong, D., & Shakespeare-Finch, J. (2011). Relationship to the bereaved and perceptions of severity of trauma differentiate elements of posttraumatic growth. *OMEGA-Journal of Death and Dying*, 63(2), 125-140.

Arya, B., & Davidson, C. (2015). Sense of coherence as a predictor of post traumatic growth. *Indian Journal of Health & Wellbeing*, 6(6), 634-636.

Augustine, A. A., & Larsen, R. J. (2012). Is a trait really the mean of states? Similarities and differences between traditional and aggregate assessments of personality. *Journal of Individual Differences*, 33(3), 131–137. <https://doi.org/10.1027/1614-0001/a000083>

Barskova, T., & Oesterreich, R. (2009). Post-traumatic growth in people living with a serious medical condition and its relations to physical and mental health: A systematic review. *Disability and Rehabilitation*, 31(21), 1709–1733. <https://doi.org/10.1080/09638280902738441>

Bartone, P. T., & Bowles, S. V. (2021). Hardiness predicts post-traumatic growth and well-being in

- severely wounded servicemen and their spouses. *Military medicine*, 186(5-6), 500-504.
- Bellizzi, K.M., Blank, T.O. (2006). Predicting posttraumatic growth in breast cancer survivors. *Health Psychology*, 25(1), 47.
- Benet-Martínez, V., & John, O. P. (1998). Los Cinco Grandes across cultures and ethnic groups: Multitrait-multimethod analyses of the Big Five in Spanish and English. *Journal of personality and social psychology*, 75(3), 729.
- Bensimon M. (2012). Elaboration on the association between trauma, PTSD and posttraumatic growth: The role of trait resilience. *Personality and Individual Differences*, 52(7), 782-787.
- Birgit Kleim and Anke Ehlers, (2009). Evidence for a Curvilinear Relationship Between Posttraumatic Growth and Posttrauma Depression and PTSD in Assault Survivors. *Journal of Traumatic Stress*, 22, (1), 45–52
- Bolu, A., Erdem, M., & Öznur, T. (2014). Travma Sonrası Stres Bozukluğu. *Anatolian Journal of Clinical Investigation*, 8(2).
- Bonanno, G. A., Wortman, C. B., & Nesse, R. M. (2004). Prospective patterns of resilience and maladjustment during widowhood. *Psychology and aging*, 19(2), 260.
- Bossick B.E. (2008). *An Empirical Examination of The Relationship Between Posttraumatic Growth and The Personality Traits of Hardiness, Sense of Coherence, Locus of Control, Self-Efficacy, Resilience, and Optimism*. Dissertation Degree Doctor of Philosophy, The Graduate Faculty of The University of Akron.
- Brockhouse, R., Msetfi, R. M., Cohen, K., & Joseph, S. (2011). Vicarious exposure to trauma and growth in therapists: The moderating effects of sense of coherence, organizational support, and empathy. *Journal of traumatic stress*, 24(6), 735-742.
- Bussell, V. A. ve Naus, M. J. (2010). A longitudinal investigation of coping and posttraumatic growth in breast cancer survivors. *Journal of Psychosocial Oncology*, 28(1), 61-78. doi.org/10.1080/07347330903438958
- Butler, L. D., Blasey, C. M., Garlan, R. W., McCaslin, S. E., Azarow, J., Chen, X. H., ... & Spiegel, D. (2005). Posttraumatic growth following the terrorist attacks of September 11, 2001: Cognitive, coping, and trauma symptom predictors in an internet convenience sample. *Traumatology*, 11(4), 247-267.
- Calhoun, L. G., & Tedeschi, R. G. (1999). *Facilitating posttraumatic growth: A clinician's guide*. New Jersey: Routledge.
- Calhoun, L.G., Cann, A. & Tedeschi, R.G. (2010). The post-traumatic growth model: Sociocultural considerations. In T. Weiss & R. Berger (Eds.), *Posttraumatic growth and culturally competent practice: Lessons learned from around the globe* (pp. 1-14). Hoboken, NJ, US: John Wiley & Sons Inc
- Carver, C. S. (1998). Resilience and thriving: Issues, models, and linkages. *Journal of social issues*, 54(2), 245-266.
- Carver, C. S., & Scheier, M. F. (1994). Situational coping and coping dispositions in a stressful transaction. *Journal of personality and social psychology*, 66(1), 184.
- Carver, C.S., Antoni, M, H. (2004). Finding benefit in breast cancer during the year after diagnosis predicts better adjustment 5 to 8 years after diagnosis. *Health psychology*, 23(6), 595.
- Chauvin, B., Hermand, D., & Mullet, E. (2007). Risk Perception and Personality Facets. *Risk Analysis*. 1, 171-185.
- Cole, A. S., & Lynn, S. J. (2010). Adjustment of sexual assault survivors: Hardiness and acceptance coping in posttraumatic growth. *Imagination, Cognition and Personality*, 30(1), 111–127. https://doi.org/10.2190/IC.30.1.g
- Confino, D., Einav, M., & Margalit, M. (2023). Post-traumatic Growth: The Roles of the Sense of Entitlement, Gratitude and hope. *International Journal of Applied Positive Psychology*, 8(2), 453-465. https://doi.org/10.1007/s41042-023-00102-9
- Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1992). Normal personality assessment in clinical practice: The neo personality inventory. *Psychological Assessment*, 4, 5-13.
- Cryder, C., Kilmer, R., Tedeschi, R., & Calhoun, L.(2006). An exploratory study of posttraumatic

growth in children following a natural disaster. *American Journal of Orthopsychiatry*, 76, 65–69.

Currier, J. M., Lisman, R., Irene Harris, J., Tait, R., & Erbes, C. R. (2013). Cognitive processing of trauma and attitudes toward disclosure in the first six months after military deployment. *Journal of clinical psychology*, 69(3), 209-221.

Çetinceli, K., & Mücevher, M. H. (2023). Kadın Çalışanlarda İş Stresinin ve İşe Yabancılaşmanın Umud ve İyimserlik ile Olan İlişkisi. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi*, 7(1), 24-43.

Çiçek, İ., & Aslan, A. E. (2020). Kişilik ve beş faktör kişilik özellikleri: Kuramsal bir çerçeve. *Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi*, 10(1), 137-147.

Dekel, S., Ein-Dor, T., & Solomon, Z. (2012). Posttraumatic growth and posttraumatic distress: A longitudinal study. *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy*, 4(1), 94.

DeYoung, C. G. (2006). Higher-order factors of the big five in a multi-informant sample. *Journal of Personality and Social Psychology*, 91(6), 1138–51.

Duman, N. (2019). Travma Sonrası Büyüme ve Gelişim. *Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi*, 4(7), 178-184.

Dürü, Ç. (2006). *Travma sonrası stres belirtileri ve travma sonrası büyümenin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ve bir model önerisi* (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Eriksson M, Lindström B. (2005). Validity of Antonovsky's sense of coherence scale: a systematic review. *J Epidemiol Community Health*, 59(6), 460–466. doi:10.1136/jech.2003.01808523.

Erten, R., & Kocakaya, R. (2020). Travma Sonrası Büyüme ve Anlam: Bir Vaka Örneği. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (31), 189–204.

Ezerbolat, M., & Özpolat, A. G. Y. (2016). Travma sonrası büyüme: travmaya iyi yanından bakmak. *Kriz Dergisi*, 24(1).

Folkman, S., & Lazarus, R. S. (1985). If it changes it must be a process: study of emotion and coping during three stages of a college examination. *Journal of personality and social psychology*, 48(1), 150.

Frazier, P., Conlon, A., & Glaser, T. (2001). Positive and negative life changes following sexual assault. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 69, 1048–1055. <http://dx.doi.org/10.1037/0022-006X.69.6.1048>

Goldberg, L. R. (1993). The Structure of Phenotypic Personality Traits. *American Psychologist*, 48(1), 26-34.

Gülyol, Y. (2024). Deprem Kaynaklı İkincil Travmatik Strese Genel Bir Bakış. *Habitus Toplumbilim Dergisi*, 5(5), 37-60.

Habip, B. (2019). *Psikanalizin içinden*. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Harju, B. L. and Bolen, L. M. (1998), “The Effects of Optimism on Coping and Perceived Quality of Life of College Students”. *Journal of Social Behavior and Personality*, 13(2), 185-200.

Helgeson, V.S., Reynolds, K.A., Tomich, P.L. (2006). A meta-analytic review of benefit finding and growth. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 74(5), 797.

Herman, J.L. (2020). *Travma ve İyileşme* (8.Basım). İstanbul. Literatür Yayıncılık.

Hobfoll, S. E., Hall, B. J., Canetti-Nisim, D., Galea, S., Johnson, R. J., & Palmieri, P. A. (2007). Refining our understanding of traumatic growth in the face of terrorism: Moving from meaning cognitions to doing what is meaningful. *Applied Psychology*, 56(3), 345-366. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.995981>

Janoff-Bulman, R. (1982). Esteem and control bases of blame: "Adaptive" strategies for victims versus observers. *Journal of Personality*, 50(2), 180–192. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.1982.tb01022.x>

Janoff-Bulman, R. (2006). Schema-Change perspectives on posttraumatic growth. In L. G. Calhoun & R. G. Tedeschi (Eds.), *Handbook of posttraumatic growth: Research and practice* (pp. 81-99). Mahwah, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

John, O. P., Naumann, L. P., & Soto, C. J. (2008). Paradigm shift to the integrative Big Five trait taxonomy: History, measurement, and conceptual issues. In O. P. John, R. W. Robins, & L. A. Pervin (Eds.), *Handbook of personality: Theory and research* (3rd ed., pp. 114–158). The Guilford Press.

- Joseph, S., Linley, P.A. (2005). Positive adjustment to threatening events: An organismic valuing theory of growth through adversity. *Review of General Psychology*, 9(3), 262.
- Joseph, S., Murphy, D. & Regel, S. (2012). An affective- cognitive processing model of post traumatic growth. *Clinical Psychology & Psychotherapy*, 19, 316-325.
- Karancı, A. N., Işıklı, S., Aker, A. T., Gül, E. İ., Erkan, B. B., Özkol, H., & Güzel, H. Y. (2012). Personality, posttraumatic stress and trauma type: Factors contributing to posttraumatic growth and its domains in a Turkish community sample. *European journal of psychotraumatology*, 3(1), 17303.
- Karancı, N. A., Aker, T. A., & Işıklı, S. (2009). Yetişkinlerde travmatik olay yaşama yaygınlığı, travma sonrası stres bozukluğu ve travma sonrası gelişimin değerlendirilmesi. TUBİTAK SOBAG Projesi (107K323).
- Kashdan, T. B., Morina, N., & Priebe, S. (2009). Post-traumatic stress disorder, social anxiety disorder, and depression in survivors of Kosova War: Experimental avoidance as a contributor to distress and quality of life. *Journal of Anxiety Disorder*, 23, 185-196.
- Kleim, B., & Ehlers, A. (2009). Evidence for a curvilinear relationship between posttraumatic growth and posttrauma depression and PTSD in assault survivors. *Journal of Traumatic Stress: Official Publication of The International Society for Traumatic Stress Studies*, 22(1), 45-52.
- Kleim, B., & Ehlers, A. (2009). Evidence for a curvilinear relationship between post-traumatic growth and posttrauma depression and PTSD in assault survivors. *Journal of Traumatic Stress*, 22(1), 45-52.
- Kobasa, S. C. (1979). Stressful life events, personality, and health: an inquiry into hardiness. *Journal of personality and social psychology*, 37(1), 1.
- Kobasa, S. C., Maddi, S. R., & Puccetti, M. C. (1982). Personality and exercise as buffers in the stress-illness relationship. *Journal of Behavioral Medicine*, 5, 391-404.
- Lechner, S., Carver, C., Antoni, M., Weaver, K., & Phillips, K. (2006). Curvilinear associations between benefit finding and psychosocial adjustment to breast cancer. *Journal of Consulting & Clinical Psychology*, 74, 828-840.
- Lepore, S. J., & Revenson, T. A. (2006). *Resilience and Posttraumatic Growth: Recovery, Resistance, and Reconfiguration*. In L. G. Calhoun & R. G. Tedeschi (Eds.), *Handbook of posttraumatic growth: Research & practice* (pp. 24-46). Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- Levers, L. L. (Ed.). (2012). *Trauma counseling: Theories and interventions*. New York, NY: Springer.
- Levine, P. A. (2017). *Travma ve anı*. (çev. P. Savaş). İstanbul: Butik Yayıncılık.
- Levine, S. Z., Laufer, A., Stein, E., Hamama-Raz, Y., & Solomon, Z. (2009). Examining the relationship between resilience and posttraumatic growth. *Journal of traumatic stress: Official publication of the international society for traumatic stress studies*, 22(4), 282-286.
- Levy, A. J. & Wall, J. C. (2000). Children who have witnessed community homicide: Incorporating risk and resilience in clinical work. *Families in Society. The Journal of Contemporary Human Services*, 81, 402-411.
- Lindblad C, Sandelin K, Petersson LM, Rohani C, Langius-Eklöf EA. (2016). Stability of the 13-item sense of coherence (SOC) scale: a longitudinal prospective study in women treated for breast cancer. *Qual Life Res*, 25(3), 753-760. doi:10.1007/s11136-015-1114-424.
- Linley PA, Joseph S, Loumidis K. (2005). Trauma work, sense of coherence, and positive and negative changes in therapists. *Psychother Psychosom*, 74, 185-8. <https://doi.org/10.1159/000084004>.
- Linley, P. A. & Joseph, S. (2004). Positive change following trauma and adversity: A review. *Journal of Traumatic Stress*, 17, 11-21.
- Maddi, S. R. (2002). The story of hardiness: Twenty years of theorizing, research, and practice. *Consulting psychology journal: practice and research*, 54(3), 173.
- Maddi, S. R. (2005). On Hardiness and Other Pathways to Resilience. *American Psychologist*, 60(3), 261-262. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.60.3.261>

- Maddi, S. R. (2006). Hardiness: The courage to grow from stresses. *The journal of positive psychology*, 1(3), 160-168.
- Maercker, A., & Zoellner, T. (2004). The Janus face of self-perceived growth: Toward a two-component model of posttraumatic growth. *Psychological inquiry*, 15(1), 41-48.
- Maguen, S., Vogt, D. S., King, L. A., King, D. W., & Litz, B. T. (2006). Posttraumatic growth among Gulf War I veterans: The predictive role of deployment-related experiences and background characteristics. *Journal of Loss and Trauma*, 11, 373-388.
- McLean, C. P., Handa, S., Dickstein, B. D., Benson, T. A., Baker, M. T., Isler, W. C., ... & Litz, B. T. (2013). Posttraumatic growth and posttraumatic stress among military medical personnel. *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy*, 5(1), 62.
- Min JA, Lee CU, Hwang SI, Shin JI, Lee BS, Han SH, Ju H, Lee CY, Chae JH. (2014). The moderation of resilience on the negative effect of pain on depression and post-traumatic growth in individuals with spinal cord injury. *Disability and rehabilitation*, 36(14), 1196-1202.
- Norman M (1989) *These Good Men: Friendships Forged From War*, New York, 139- 141.
- O'Leary, V. E., Alday, C. S., & Ickovics, J. R. (1998). Models of life change and posttraumatic growth. In R. G. Tedeschi, C. L., Park., & L. G., Calhoun (Eds.), *Posttraumatic growth: Positive changes in the aftermath of crisis* (pp. 127-147). London: Lawrence Erlbaum Associates.
- O'Leary & Ickovics JR. (1995). Resilience and thriving in response to challenge: an opportunity for a paradigm shift in women's health. *Womens Health*, 1(2), 121-42. PMID: 9373376.
- Özcan, N. A., & Arslan, R. (2020). Travma Sonrası Stres ile Travma Sonrası Büyüme Arasındaki İlişkide Sosyal Desteğin ve Maneviyatın Aracı Rolü. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 19(73), 299-314.
- Özgüler, N. E., Maner, F., Çobanoğlu, S., Aker, A. T., & Karamustafalıoğlu, O. (2004). Yaşlılarda travma sonrası stress bozukluğunda eş tanı. *Düşünen Adam dergisi*, 17(3), 141-145.
- Park, C. L. (2004). The notion of stress-related growth: Problems and prospects. *Psychological Inquiry*, 15, 69-76.
- Park, C. L., & Ai, A. L. (2006). Meaning making and growth: New directions for research on survivors of trauma. *Journal of Loss and Trauma*, 11(5), 389- 407.
- Park, C. L., Lechner, S. C., Antoni, M. H., & Stanton, A. L. (2009). Medical Illness And Positive Life Change: Can Crisis Lead To Personal Transformation?, *American Psychological Association*.
- Polatinsky, S., ve Esprey, Y. (2000). An assessment of gender differences in the perception of benefit resulting from the loss of a child. *Journal of Traumatic Stress: Official Publication of The International Society for Traumatic Stress Studies*, 13(4), 709- 718.
<https://doi.org/10.1023/A:1007870419116>
- Powell, S., Rosner, R., Butollo, W., Tedeschi, R. G. ve Calhoun, L. G. (2003). Posttraumatic growth after war: A study with former refugees and displaced people in Sarajevo. *Journal of Clinical Psychology*, 59(1), 71-83. doi: 10.1002/jclp.10117
- Ptacek, J. T., Smith, R. E., & Zanas, J. (1992). Gender, appraisal, and coping: A longitudinal analysis. *Journal of personality*, 60(4), 747-770.
- Ragger, K., Hiebler-Ragger, M., Herzog, G., Kapfhammer, H. P., & Unterrainer, H. F. (2019). Sense of coherence is linked to post-traumatic growth after critical incidents in Austrian ambulance personnel. *BMC psychiatry*, 19, 1-11.
- Rubenzler, S. J., & Faschingbauer, T. R. (2004). *Personality, character & leadership in the White house: Psychologists assess the presidents*. Washington: Brassey's Inc.
- Ruppert, F. (2014) *Travma, bağlanma ve aile konstelasyonları* (çev. F. Zengin). İstanbul: Kaknüs. (Orijinal çalışmanın basım tarihi 2008).
- Rutter, M. (1985). Resilience in the face of adversity: Protective factors and resistance to psychiatric disorder. *British Journal of Psychiatry*, 147, 598-611.
- Salim, J., Wadey, R., & Diss, C. (2015). Examining the relationship between hardiness and perceived stress-related growth in a sport injury context.

Psychology of Sport and Exercise, 19, 10–17. <https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2014.12.004>

Savcı, M., & Aysan, F. (2014). Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Stres Düzeyi İle Stresle Başa Çıkma Stratejileri Arasındaki İlişki. *Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, (3), 44-56.

Schaefer, J. A. & Moss, R. H. (1998). *The context for posttraumatic growth: Life crises, individual and social resources, and coping*. Ed. R. G. Tedeschi, C. L. Park, L.G. Calhoun. Posttraumatic growth: Positive changes in the aftermath of crisis. Mahwah. NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Schaefer, J. A., & Moos, R. H. (1992). *Life crises and personal growth*. In B. N. Carpenter (Eds.), *Personal coping: Theory, research, and application* (pp. 149–170). Westport, CT: Praeger Publishers.

Scheier, M. F., & Carver, C. S. (1987). Dispositional optimism and physical well-being: The influence of generalized outcome expectancies on health. *Journal of Personality*, 55(2), 169-210

Schmidt, S. D., Blank, T. O., Bellizzi, K. M. & Park, C. L. (2012). The relationship of coping strategies, social support, and attachment style with posttraumatic growth in cancer survivors. *Journal of Health Psychology*, 17(7), 1033-1040. doi.org/10.1177/1359105311429203

Schroevers, M. J., Helgeson, V. S., Sanderman, R. & Ranchor, A. V. (2010). Type of social support matters for prediction of posttraumatic growth among cancer survivors. *Psycho-Oncology*, 19(1), 46-53. [doi:10.1002/pon.1501](https://doi.org/10.1002/pon.1501)

Schulenberg, S. E. (Ed.). (2020). *Positive psychological approaches to disaster: Meaning, resilience, and posttraumatic growth*. Springer Nature Switzerland AG. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-32007-2>

Schultz, J. M., Espinola, M., Rechkemmer, A., Cohen, M. A., & Espinel, Z. (2016). *Prevention of Disaster Impact and Outcome Cascades*, In: Israelashvili M, Romano JL (eds.): Cambridge Handbook of International Prevention Science. 492-519.

Schulz, U., Mohamed, N.E. (2004). Turning the tide: Benefit finding after cancer surgery. *Social Science & Medicine*, 59(3), 653-662.

Seligman, E.P. (2007). *Gerçek mutluluk*. (çev. S. Kunt-Akbağ). Ankara: HYB

Shakespeare-Finch, J. E., Smith, S. G., Gow, K. M., Embelton, G., & Baird, L. (2003). The prevalence of post-traumatic growth in emergency ambulance personnel. *Traumatology*, 9(1), 58- 71. <https://doi.org/10.1177/153476560300900104>

Shakespeare-Finch, J., & Lurie-Beck, J. (2014). A meta-analytic clarification of the relationship between posttraumatic growth and symptoms of posttraumatic distress disorder. *Journal of anxiety disorders*, 28(2), 223-229.

Snyder, C. R., Sympton, S. C., Ybasco, F. C., Borders, T. F., Babyak, M. A., & Higgins, R. L. (1996). Development and validation of the state hope scale. *Journal of Personality and Social Psychology*, 70(2), 321- 335.

Solomon, Z., & Dekel, R. (2007). Posttraumatic stress disorder and posttraumatic growth among Israeli ex-POWs. *Journal of Traumatic Stress*, 20, 303–312.

Somer, O., Korkmaz, M., & Tatar, A. (2002). Beş faktör kişilik envanteri'nin geliştirilmesi-1: Ölçek ve alt ölçeklerin oluşturulması. *Türk Psikoloji Dergisi*, 17(49), 21–33.

Song, H., & Lee, Y. S. (2011). The effects of hardiness and emotional intelligence on posttraumatic growth: Active coping as a mediating variable. *Korean journal of counseling*, 12(4), 1231-1246. doi.org/10.15703/kjc.12.4.201108.1231

Stockton, H., Hunt, N. ve Joseph, S. (2011). Cognitive processing, rumination and posttraumatic Growth. *Journal of Traumatic Stress*, 24(1), 85-92

Sungur, M. Z. (1999). İkincil travma ve sosyal destek. *Klinik Psikiyatri*, 2(2), 105-108.

Snyder, R., Irwing, L., & Anderson, R. (1991). *Hope and health: Measuring the will and the ways*. C. R. Snyder & D. R. Forsyth (Ed.). Handbook of social and clinical psychology (ss. 355-361). New York: Pergamon.

Tarhan, S., & Bacanlı, H. (2015). Sürekli Umud Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. *The Journal of Happiness & Well-Being*, 3(1), 1-14.

- Taylor, S. E. (1983). Adjustment to threatening events: A theory of cognitive adaptation. *American Psychologist*, 38, 1161–1173.
- Taylor, S. E., & Armor, D. A. (1996). Positive illusions and coping with adversity. *Journal of Personality*, 64, 873–898.
- Taylor, S. E., Kemeny, M. E., Reed, G. M., Bower, J. E., & Gruenewald, T. L. (2000). Psychological resources, positive illusions, and health. *American Psychologist*, 55, 99–109.
- Tedeschi, R. G. & Calhoun, L. G. (2004). Posttraumatic growth: Conceptual foundations and empirical evidence. *Psychological Inquiry*, 15, 1-18.
- Tedeschi, R. G., & Moore, B. A. (2016). *The posttraumatic growth workbook: Coming through trauma wiser, stronger, and more resilient*. New Harbinger Publications.
- Tedeschi, R. G., Calhoun, L. G., & Cann, A. (2007). Evaluating resource gain: Understanding and misunderstanding posttraumatic growth. *Applied Psychology: An International Review*, 56(3), 396–406. <https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.2007.00299.x>
- Tedeschi, R. G., Park, C. L., & Calhoun, L. G. (1998). Posttraumatic growth: Conceptual issues. Ed. R. G. Tedeschi, C. L. Park & L. G. Calhoun. *Posttraumatic growth: Positive changes in the aftermath of crisis*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Tedeschi, R. G., Shakespeare-Finch, J., Taku, K., & Calhoun, L. G. (2018). *Posttraumatic growth: Theory, research, and applications*. Routledge.
- Tedeschi, R.G., Calhoun, L.G. (1996). The Posttraumatic Growth Inventory: Measuring the positive legacy of trauma. *Journal of Traumatic Stress*, 9(3), 455-471.
- Thornton, A. A., & Perez, M. A. (2006). Posttraumatic growth in prostate cancer survivors and their partners. *Psycho-Oncology: Journal of the Psychological, Social and Behavioral Dimensions of Cancer*, 15(4), 285-296.
- Ullman, S.E., & Peter-Hagene, L. (2014). Social reactions to sexual assault disclosure, coping, perceived control, and PTSD symptoms in sexual assault victims. *Journal of Community Psychology*, 42(4), 495-508.
- Veith, I. (1977) 'Four thousand years of hysteria' in Mardi J. Horowitz (ed.), *Hysterical Personality* (New York: Jason Aronson), 7-93.
- Wagnild, G. M., & Collins, J. A. (2009). Assessing resilience. *Journal of psychosocial nursing and mental health services*, 47(12), 28-33.
- Wardell B., M., & Wicks, J. W. (2012). *Primer on posttraumatic growth*. New Jersey: John Wiley.
- Westphal M, Bonanno GA. (2007) Posttraumatic growth and resilience to trauma: Different sides of the same coin or different coins? *Applied Psychology*, 56(3), 417-427.
- Westphal, M., & Bonanno, G. A. (2007). Posttraumatic growth and resilience to trauma: Different sides of the same coin or different coins?. *Applied Psychology*, 56(3), 417-427.
- Widows, M. R., Jacobsen, P. B., Booth-Jones, M., & Fields, K. K. (2005). Predictors of posttraumatic growth following bone marrow transplantation for cancer. *Health psychology*, 24(3), 266.
- Wilson, J. (1994). The Historical Evolution of PTSD Diagnostic Criteria: From Freud to DSM-IV, *Journal of Traumatic Stress*, 7(4), 681- 698
- Wright, M. O. & Masten, A. S. (2015). Pathways to resilience in context. In L.C. Theron, L. Liebenberg and M. Ungar (Eds.), *Youth Resilience and Culture: Commonalities and Complexities* (pp. 3-23). New York: Springer.
- Wu, G., Feder, A., Cohen, H., Kim, J. J., Calderon, S., Charney, D. S., & Mathé, A. A. (2013). Understanding resilience. *Frontiers in behavioral neuroscience*, 7, 10.
- Yi, J., & Kim, M. A. (2014). Postcancer experiences of childhood cancer survivors: how is posttraumatic stress related to posttraumatic growth?. *Journal of traumatic stress*, 27(4), 461-467.
- Zoellner, T., & Maercker, A. (2006). Posttraumatic growth in clinical psychology—A critical review and introduction of a two component model. *Clinical psychology review*, 26(5), 626-653.